

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082586-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FRANCISCO GONCALVES PEDRAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. COMBODART. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INDICADO PARA O QUADRO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. TEMA 1234. NÃO APLICAÇÃO QUANTO À COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5082586-97.2024.4.02.5101

510014854464 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082586-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FRANCISCO GONCALVES PEDRAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão do juízo de origem que concedeu a tutela provisória nos seguintes termos (evento 34, DESPADEC1):

"Ante todo o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus, de acordo com as suas atribuições previstas nos atos normativos vigentes, forneçam ao autor, pelo tempo que durar seu tratamento, o medicamento Combodart®, de acordo com a posologia de seu médico assistente.

Intime-se, inicialmente, o Estado do Rio de Janeiro para cumprimento da obrigação em tela, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da respectiva intimação."

De acordo com o magistrado o NAT foi claro em afirmar que não há no SUS alternativa terapêutica para o Autor nem sequer PCDT para sua patologia, de modo que preenchidos os requisitos previstos no tema 106 do STJ.

A União alega preliminarmente a sua ilegitimidade com base no tema 1234, recentemente decidido pelo STF. No mérito alega a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e o não cumprimento dos requisitos previstos pelo tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não padronizados.

Efeito suspensivo indeferido no Evento 4.

É o breve relatório.

VOTO

A parte autora foi diagnosticada com hiperplasia prostática benigna (HPB), necessitando fazer uso do medicamento dutasterida ,5 mg + cloridrato de tansulosina 0,4 mg (Cobodart) a fim de controlar o volume de sua próstata e melhorar o fluxo urinário, reduzindo o risco de retenção urinária aguda (evento 1, ANEXO2 pags. 9/14).

O NAT em seu parecer esclarece que se trata de medicamento não padronizado no SUS, mas que está indicado para o quadro clínico do Autor. Também afirma que não há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou PCDT publicado no Ministério da Saúde para a

III – CONCLUSÃO

1. Informa-se que o pleito **dutasterida 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg** (Combodart®) possui indicação para tratamento do quadro clínico apresentado pelo Autor, conforme documento médico analisado.
2. Quanto à disponibilização, no âmbito do SUS, informa-se que **dutasterida 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg** (Combodart®) não integra uma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) dispensados pelo SUS, não cabendo seu fornecimento a nenhuma das esferas de gestão do SUS.
3. Elucida-se que o medicamento pleiteado não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC³.
4. Cabe explicar que a associação pleiteada é composta fármacos pertencentes às seguintes classes farmacológicas: *inibidor 5-alfa-redutase (dutasterida)* e *alfa-1-bloqueador (tansulosina)*.
5. Com base nisso, cumpre informar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) listou no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) os seguintes medicamentos para o tratamento da HPB: *inibidor 5-alfa-redutase (finasterida 5mg)* e *alfa-1-bloqueador (mesilato de doxazosina 2mg e 4mg)*.
6. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) destina-se à aquisição de medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Básica à saúde. O financiamento desse componente é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios⁴.
7. A execução do CBAF no Estado do Rio de Janeiro é descentralizada para os Municípios, os quais são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do referido componente, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente (Deliberação CIB-RJ nº 5.743 de 14 de março de 2019).
8. Verifica-se que a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do Município do Rio de Janeiro, publicada em 2018, não contemplou os medicamentos finasterida e mesilato de doxazosina para o atendimento no âmbito da atenção básica.
9. Tendo isso em vista, não há medicamentos padronizados nas esferas de gestão do SUS que se apresentem como alternativa terapêutica ao pleito em tela.
10. Informa-se que ainda não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas publicado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença em questão⁵.
11. O medicamento **dutasterida 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg** (Combodart®) possui registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No tocante à alegação de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a urgência e necessidade do insumo pleiteado encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não cabendo afastá-los em razão de alegações genéricas e não comprovadas por parte da União.

Entendo, ainda, que deva ser aplicado o princípio da proporcionalidade para afastar a irreversibilidade do provimento adotado, a fim de que seja protegido o interesse maior lastreado no direito constitucional à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB/88, em detrimento do interesse financeiro do Estado.

No que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada por conta da ausência de tal requisito teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.^a Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

“SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102.”

Observa-se que a decisão impugnada determinou o fornecimento do medicamento pelos réus de acordo com suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, já tendo direcionado o cumprimento para o Estado do Rio de Janeiro.

Com relação à questão da competência à luz do tema 1234, é de se ressaltar que houve modulação de efeitos:

*VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos **que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico**, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.*

No caso o acórdão do STF foi publicado em 11/10/2024, tendo a presente ação sido proposta antes, em 16/08/2024, não havendo, portanto, aplicação do tema 1234 quanto à competência.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM**. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.